

纤维瘤病 109 例临床特征与治疗

宁晓红 白春梅 应红艳 王毓洲

【摘要】 目的 分析纤维瘤病的临床特点及治疗。方法 对我院 1986 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日间确诊的 109 例纤维瘤病患者的临床特征、治疗情况进行总结分析。结果 109 例患者中女性 70 例, 男性 39 例, 87.2% 的患者是以肿块为首发症状, 肿块伴疼痛占 33.7%, 32.1% (35/109 例) 肿块发生在腹壁, 腹壁肿块患者中女性达 94.3%。直径 5 cm 及以上肿块占 70.5%。深部肿块直径明显大于浅表肿块, 直径分别为 (11.1 ± 5.9) cm 和 (6.8 ± 5.1) cm, $P < 0.01$ 。12 例患者接受过放射治疗, 8 例以预防术后复发为目的的患者 7 例出现放疗后复发, 平均复发时间为 2.7 年。1 例患者采用联合化疗达到部分缓解。4 例患者由于本病导致死亡。结论 手术仍是目前治疗纤维瘤病的主要手段, 放疗对部分患者也有效。

【关键词】 纤维瘤; 手术; 放射疗法; 化学疗法

【中图分类号】 R 739 **【文献标识码】** A

Clinical features and treatment of aggressive fibromatosis NING Xiao-hong, BAI Chun-mei, YING Hong-yan, WANG Yu-zhou. Oncology Department, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100032, China
Corresponding author: BAI Chun-mei, Email: baichunmei1964@yahoo.com.cn

【Abstract】 **Objective** To study the clinical features and treatment of aggressive fibromatosis (AF). **Methods** One hundred and nine the clinical characters, treatment and efficacy of each patient were reviewed. **Results** One hundred and nine pathologically diagnosed AF patients presented in Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) was analyzed. 70 females and 39 males were included with an average age of 34.0 and 36.9 yrs respectively. 87.2% of patients first presented as mass, 33.7% first presented as mass accompanying pain. 32.1% of mass located in the abdomen wall among which 94.3% were female, 51.5% of these females had a history of surgery of the abdomen. Diameter of all the masses was (7.84 ± 5.62) cm, diameter of deep mass was statistically larger than that of superior ones, which were (11.1 ± 5.9) cm and (6.8 ± 5.1) cm respectively, $P < 0.01$. Twelve patients got radiotherapy and 8 of them did it for the purpose of preventing disease recurrence. 7 out of them recurrent within an average interval of about 2.7 years. A patient whose tumor was located in the anterior mediastinum was treated with chemotherapy and had a partial response. 4 patients died of AF. **Conclusion** Operation is still most widely used therapeutic option. Radiotherapy is also effective in certain percentage of patients and medicine such as chemotherapy or NSAIDs that have not been receipted.

【Key words】 Fibroma; Surgery; Radiotherapy; Chemotherapy

纤维瘤病 (fibromatosis) 也称硬纤维瘤 (desmoid tumor), 好发年龄是 15 ~ 60 岁, 女性多于男性, 没有明显的种族差异^[1]。习惯上将发生于肢体、躯干的病理上称硬纤维瘤, 发生于其他部位的称为纤维瘤病。纤维瘤病是一种低度恶性肿瘤, 发病率低, 约占全部肿瘤的 0.03%。它以局部浸润为主要临床表现, 有容易局部复发的特点, 手术是治疗的主要方法。随着临床研究的不断开展, 放疗及药物治疗也逐渐成为重要的治疗手段。现就我院诊治的 109 例纤维瘤病患者的临床资料进行回顾性分析, 以加强临床医生对本病的了解并促进治疗的改进。

1 对象与方法

1.1 对象 1986 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日间我院诊治的纤维瘤病患者 109 例, 其中女性 70 例,

男性 39 例; 平均年龄 34 岁 (8 ~ 77 岁)。全部患者均经病理学诊断, 其中 1 例患者病理提示纤维瘤病伴部分纤维肉瘤改变。78 例为初治, 31 例为复治。肿瘤原发部位: 腹壁 35 例, 胸壁 14 例, 四肢关节 30 例, 头颈 4 例, 腹膜后 10 例, 腹膜 7 例, 腹腔 2 例, 胰腺 1 例, 盆腔 5 例, 前纵隔 1 例。肿块直径 0.8 ~ 30 cm 不等, 70.5% 的肿块直径超过 5 cm。肿块、疼痛是主要首发临床表现。

1.2 方法 回顾性调查这些纤维瘤病患者的住院及门诊病历, 对患者起病时的临床表现, 确诊时间, 肿块大小, 位置, 影像学检查的结果; 手术切除的情况; 术后复发时间, 再次手术情况 (包括手术次数及二次手术后复发情况); 是否采用放疗及放疗的剂量、效果; 药物治疗情况以及肿瘤所在部位既往手术史等进行统计并分析。比较不同部位肿块直径, 根治性手术切除比例, 术后复发时间以及 1 年、2 年、3 年和 5 年复发率。通过门诊和住院治疗以及电话随访的方式完成对患者的随访, 以了解复发、生存

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4777.2010.08.001

作者单位: 100032 中国医学科学院 中国协和医科大学北京协和医院肿瘤内科

通信作者: 白春梅, Email: baichunmei1964@yahoo.com.cn

情况。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 12.0 软件进行统计分析。采用 t 检验比较不同部位肿瘤直径,采用 χ^2 检验比较不同部位肿瘤的根治性切除率。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床资料 根据部位不同将肿块分为深部肿块和浅表肿块。深部肿块包括腹膜、腹膜后、腹腔、盆腔及纵隔肿块;浅表肿块包括胸壁、腹壁、四肢、关节、头颈部肿块。深部肿块占全部肿块的 23.9% (26/109);浅表肿块占 76.1% (83/109)。所有病灶中腹壁肿瘤所占比例最高,达 32.1%,腹壁肿瘤占浅表肿瘤的 42.2% (35/83)。腹壁肿块患者中女性占 94.3% (33/35),而且这些患者中 51.5% (17/33) 有经腹壁手术史。以肿块为首发症状的分别占 87.2% (95/109),肿块伴有疼痛的占 33.7% (32/95);以疼痛为惟一首发症状的占 6.4% (7/109),其他占 6.4% (7/109)。浅表肿块直径 (6.8 ± 5.1) cm $(0.8 \sim 30)$ cm,深部肿块直径为 (11.1 ± 5.9) cm $(3.8 \sim 23)$ cm,深部肿块直径明显大于浅表肿块 ($P < 0.01$)。位于浅表的肿块 B 型超声表现为边界不清、低回声、实性肿物;深部肿块 CT 检查提示肿瘤实性、边界不清,侵犯血管、输尿管、肠道等。5 例 (4.6%) 患者行结肠镜检查:1 例为家族性腺瘤性息肉病 (FAP) 同时发现息肉恶变,另有 2 例 FAP 未发现恶变,2 例结肠镜检查未见异常。

2.2 治疗

2.2.1 手术 98.2% (107/109) 的患者接受了手术治疗,肿块一般呈灰白色,质硬,无包膜,边界不清;个别呈鱼肉样,可以浸润包裹周围组织。根据手术时能否将肿物彻底切除将手术分为根治性切除和姑息性切除。79.4% (85/107) 患者在首次手术时行根治性切除,其余 20.6% 为姑息性切除。浅表肿块的根治性切除率明显高于深部肿块的根治性切除率,二者分别为 84.3% 和 57.7%, $P = 0.004$ 。浅表肿块中,腹壁、四肢关节、胸壁、头颈等各部位根治性切除率分别为 97.1% (34/35)、80.0% (24/30)、78.6% (11/14)、75.0% (3/4),其中腹壁肿块的根治性切除率明显高于四肢关节病变的根治性切除率 ($P < 0.05$),其他各部位的根治性切除率差异无统计学意义。

在所有接受手术的患者中,有 32.7% (35/107) 接受了多次手术,多次手术患者中男女比例为 1:1,患者的年龄、肿块直径、肿块部位、手术术式等对总手术次数没有影响,首次接受姑息或根治性手术患者最终接受总手术次数分别为 2.0 和 1.6 次,二者差异无统计学意义。深部和表浅肿块患者的平均手术次数分别为 1.3 和 1.7 次,差异亦无统计学意义。

术后复发情况:第一次手术到第一次手术后复发的时间定义为首次复发时间,所有患者的平均首次复发时间为 1840 d。随访时间超过 5 年的 75 例患者的 1 年、2 年、3 年、5 年复发率分别为 45.3%、65.4%、74.7% 和 85.3%。

2.2.2 放疗 放疗选择:12 例患者 (11.0%) 接受了放疗,其中深部肿块 3 例,均行诱导放疗;浅表肿块 9 例患者中 1 例为姑息切除后放疗,3 例为第一次根治切除后预防性放疗,5 例为首次复发手术再切除后放疗。放疗剂量为 16 ~ 56 Gy。3 例术前诱导放疗的深部肿块中 1 例放疗后病情稳定,另 2 例无法评估疗效。9 例表浅肿块放疗的患者:1 例姑息手术切除后放疗者术后 32 个月未见复发,8 例以预防复发为目的的患者 7 例出现放疗后复发,另外 1 例随访到放疗后 70 个月未见复发。放疗后平均复发时间为 2.7 年 (2 ~ 90 个月),较单纯手术后的首次复发时间有明显延长 ($P < 0.05$)。10 例患者发生了 I 至 II 度皮肤反应。无 III 度及以上放疗相关毒性。

2.2.3 化疗 仅 1 例采用了化疗。患者为青年男性,前纵隔巨大纤维瘤病,就诊时病情危重:憋气,不能平卧,出现上腔静脉综合征,按纵隔淋巴瘤给予环磷酰胺、表阿霉素及长春新碱联合化疗,患者症状明显缓解,但影像学提示病变稳定。再予 MAID (异环磷酰胺、美司钠、表阿霉素、氮烯咪胺) 方案化疗 2 个周期后肿块缩小,达到部分缓解,化疗不良反应轻微。最终行前纵隔肿块姑息性切除术。

2.2.4 其他 1 例口服舒林酸,1 例采用热疗,1 例口服三苯氧胺治疗,均为不规律治疗,疗效无法评估。

2.3 生存情况 本研究平均随访时间为 39 个月 (1 ~ 178 个月)。6 例死亡,其中 4 例死于本病,有 1 例患者 2 次手术病理均提示纤维瘤病,死于恶性肿瘤广泛转移,死亡前病理诊断为恶性软组织肿瘤,结合病史考虑为纤维瘤病恶变;其他 3 例患者肿块直径均大于 6 cm (最大者达 23 cm),首次手术均为姑息性手术,病变部位都位于深部,其中有 2 例合并 FAP。这 4 例患者的平均生存时间为 43.7 个月。

3 讨论

纤维瘤病的病因并不是十分清楚。遗传性肠息肉综合征 (Gardner 综合征)、家族性腺瘤样息肉病、腺瘤性结肠息肉病 (adenomatous polyposis coli) 基因突变、外伤、手术^[2]、雌激素有关。本研究发现肿块是主要首发临床表现,除此之外疼痛和其他表现占到 12.8%,其他表现主要是指关节附近的病变导致的关节活动受限。刘天润等^[3]的报道中疼痛发生率为 5%,与本文类似,但没有其他症状的报告,这可能与病例数及病变部位有关。性别分布上本研究再次证实了本病好发于女性,这与国内赵东兵和邵永孚^[4]及国外学者报道^[5]是一致的。

本研究将发病部位分为浅表和深部,结果发现本病的临床特征和治疗因肿瘤发生部位不同而有明显不同。首先是肿瘤直径,深部肿瘤直径明显大于表浅者,这可能是由于肿瘤深在不易被早期发现,等到出现临床症状时往往已经直径较大。其次,深部肿瘤的根治性切除率也明显下降,一是由于深部肿瘤生长时间长,体积一般较大导致手术难度增大,更重要的是深部肿瘤与周围组织关系密切,几乎都侵犯到临近的肠管、血管等,很难根治性切除。再次,浅表肿瘤的根治性切除比例也不相同,其中腹壁肿瘤是最容易被完整切除的,而头颈部、关节、四肢肿瘤就不容易被完整切除。本文中观察到的影像学改变与国内文献报道是一致的^[6]。

手术一直是最常采用的治疗手段^[7],国内有学者报道手术切除的良好效果:术后复发率较低^[8,9]。本研究发现我院手术的硬纤维瘤术后的复发率均较高,1 年复发率接近 50%,5 年复发率超过 80%,原因可能是我院就诊的患者中接近 30% 是经外院治疗并出现复发的患者。实际上术后频繁复发是本病治疗的主要难题,本研究中近 1/3 的患者进行过 1 次以上的手术也与本病容易复发的特点相吻合。有报道宽手术切缘也不能防止肿瘤复发,因此手术不应一味追求完整切除,应该在不威胁患者的生活质量和安全的前提下尽可能切除,对于手术切缘大小一直都存在着争议^[10-11]。

本组研究中有 12 例患者接受了放疗,虽然在放疗后绝大多数出现复发,但值得注意的是放疗后肿瘤复发时间较无放疗手术后复发的时间明显延长,放疗后平均复发时间达到 2.7 年。这与荟萃分析中放疗能够提高本病的局部控制率是一致的。但本研究中放疗剂量都偏小,一般小于 35 Gy,仅 2 例放疗剂量达到 50 Gy 以上,比文献报告的剂量明显低,因此可能还未完全体现放疗的最大疗效,进一步还需要大规模、前瞻性研究来了解放疗对本病生存和延缓复发的改善作用。本研究中仅有 5 例患者进行过结肠镜检查,结果 3 例 FAP 患者的临床经过都十分凶险,这与文献中提示 FAP 合并的纤维瘤病预后不佳相一致^[12-13]。对于反复复发、不能手术切除的纤维瘤病采用三苯氧胺、非甾体抗炎药物治疗,有效率近 50%^[14],国内类似报道较少见^[15]。对手术治疗效果不理想的患者采用这类非细胞毒性药物治疗应该受到重视。国外报道采用化疗治疗不能手术的纤维瘤病,虽然由于本病的发病率低,所以这些研究的样本数都很小,但已经充分证实了化疗在纤维瘤病治疗中的有效性^[16-17]。对深部不能切除或者术后复发生长迅速的纤维瘤病应该积极考虑化疗。109 名患者中 1 例恶变,赵东兵和陈宏业等^[4,18]均有类似报道,提示本病是有恶变可能的。依据本文的分析结果,

我们提出如下建议:手术宜注重安全性,不要盲目追求根治性切除;化疗及非细胞毒性药物治疗应该受到更多的重视,尤其对深部或反复复发危及生命的患者;放疗的采用应该更加广泛和规范地采用。随着人们对本病研究的不断深入,会有更多的患者从合理的治疗中获益。

参考文献

- [1] Hansmann A, Adolph C, Vogel T, et al. High-dose tamoxifen and sulindac as first-line treatment for desmoid tumors. *Cancer*, 2004, 100(3):612-620.
- [2] Schlemmer M. Desmoid tumors and deep fibromatoses. *Hematol Oncol Clin North Am*, 2005, 19(3):565-571, vii-viii.
- [3] 刘天润,杨安奎,陈福进,等. 侵袭性纤维瘤 20 例临床分析. *肿瘤学杂志*, 2005, 11(6):454-455.
- [4] 赵东兵,邵永孚. 硬纤维瘤的临床特点-附 100 例病例报告. *癌症*, 2000, 19(2):173-174.
- [5] Kumar V, Khanna S, Khanna AK, et al. Desmoid tumors: experience of 32 cases and review of the literature. *Indian J Cancer*, 2009, 46(1):34-39.
- [6] 吴爱兰,孔祥泉,徐海波,等. 腹部外硬纤维瘤的磁共振成像诊断. *放射学实践*, 2007, 22(3):278-281.
- [7] Stoeckle E, Coindre JM, Longy M, et al. A critical analysis of treatment strategies in desmoid tumours: a review of a series of 106 cases. *Eur J Surg Oncol*, 2009, 35(2):129-134.
- [8] 杨维良,张好刚,张东伟,等. 86 例腹壁硬纤维瘤的临床分析. *中华普通外科杂志*, 2007, 22(10):736-737.
- [9] 翟松堂,翟涛,乔国霞. 24 例硬纤维瘤的诊断与治疗. *河南外科学杂志*, 2006, 12(2):42.
- [10] Bertani E, Chiappa A, Testori A, et al. Desmoid tumors of the anterior abdominal wall: results from a monocentric surgical experience and review of the literature. *Ann Surg Oncol*, 2009, 16(6):1642-1649.
- [11] 王坤,尹望平. 腹壁外侵袭性纤维瘤病的手术治疗. *中国临床医学*, 2007, 14(2):265-266.
- [12] Speake D, Evans DG, Lalloo F, et al. Desmoid tumours in patients with familial adenomatous polyposis and desmoid region adenomatous polyposis coli mutations. *Br J Surg*, 2007, 94(8):1009-1013.
- [13] 于恩达,楼征,徐晓东,等. 家族性腺瘤性息肉病伴发硬纤维瘤的诊断和治疗. *中华普通外科杂志*, 2006, 21(3):179-181.
- [14] 费阳,李基业. 硬纤维瘤的治疗进展. *西南国防医药*, 2008, 18(1):146-147.
- [15] 王革非,任建安,黎介寿. Gardner 综合征. *中华消化外科杂志*, 2007, 6(5):351-355.
- [16] Al-Otaibi ML, Turcotte RE, Hings I, et al. Low-dose chemotherapy for extra-abdominal desmoid tumor. *Saudi Med J*, 2008, 29(12):1730-1740.
- [17] Gega M, Yanagi H, Yoshikawa R, et al. Successful chemotherapeutic modality of doxorubicin plus dacarbazine for the treatment of desmoid tumors in association with familial adenomatous polyposis. *J Clin Oncol*, 2006, 24(1):102-105.
- [18] 陈宏业,韩子民,王冰. 臀部硬纤维瘤术后多次复发恶变一例. *临床外科杂志*, 2003, 11(supple):11.

(收稿:2010-05-13)

(本文编辑:李晔)